Sujet n°3 : Douleur abdominale

Spécialité : Anesthésie-réanimation

Date : 8/02
Auteur : Marion BUISSET (DESAR 1 MAR Lyon)
Relecteur(s) : Alexis PROVENCHERE (DASAR 1 Toulouse) et Lucie Lou VIAL (DESAR 2 Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	synthèse de résultats d'examens paracliniques
Domaine d'apprentissage secondaire	stratégie diagnostique
Situation(s) de départ en lien avec la station	Élévation des enzymes pancréatiques ; Douleur abdominale
Item(s) en lien avec la station	Pancréatite aigue
Matériel nécessaire à la station	bilan biologique et mot des urgences à donner directement
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne des urgences et vous prenez la relève auprès de votre co-interne. Il vous informe de l'arrivée d'un patient de 55 ans présentant une douleur abdominale épigastrique transfixiante, soulagée par la position en chien de fusil. Il lui a prescrit un bilan biologique qu'il n'a pas encore eu le temps d'étudier mais qui vient de sortir. Il vous laisse également la fiche du patient où il a consigné l'histoire de la maladie.

Consignes :

Vous devez en 8 minutes :
- Analyser de manière complète le bilan biologique du patient.
- Énoncer votre diagnostic complet et justifié
- Citer les examens complémentaires à effectuer en justifiant leur intéret

Vous ne devez pas :
- Énoncer la prise en charge

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Tache 1			
1.	Énonce au moins 3 éléments normaux parmis : pas d'anémie, pas de thrombopénie, pas de troubles ioniques ou kaliémie et natrémie normales, pas d'insuffisance rénale	*1 pt*	☐
2.	Énonce une hyperleucocytose prédominant sur les PNN ou avec polynucléose	*1 pt*	☐
3.	Énonce une cytolyse hépatique prédominant sur les ASAT	*1 pt*	☐
4.	Énonce des PAL et des GGT augmentés ou des signes de cholestase		
5.	Énonce une lipase augmentée à plus de 3 fois la normale	*1 pt*	☐
Tache 2			
6.	Diagnostique une pancréatite aiguë ET justifie par une douleur abdominale typique et une lipasémie > 3N	*1pt*	☐
7.	Énonce le terme de pancréatite aiguë grave ET justifie par la présence d'un SRIS ou de défaillances d'organes	*1 pt*	☐
8.	Diagnostique un syndrome de réponse inflammatoire systémique ou SRIS associé ET justifie par au moins 2 parmi fièvre > 38°C, hyperleucocytose > 12G/L, FR > 20/m, fréquence cardiaque > 90 bpm	*1 pt*	☐
9.	Évoque une possible étiologie alcoolique au vu de l'alcoolisme chronique/alcoolémie positive	*1 pt*	☐
10.	Évoque une possible étiologie lithiasique au vu des antécédents de douleur à type de colique hépatique ET de la cytolyse hépatique	*1 pt*	☐
Tache 3			
11.	Demande une échographie abdominale dans les 48h ET justifie qu'il faut éliminer une origine biliaire ou que c'est à visée étiologique	*1 pt*	☐
12.	Demande un scanner abdomino pelvien injecté après 72h ET justifie que cela permettra de rechercher des signes de gravités ou nécrose pancréatique/coulées de nécrose/calcul du score CTSI	*1 pt*	☐
13.	Demande un dosage de la calcémie et des triglycérides ET justifie que c'est à visée étiologique	*1 pt*	☐
14.	Demande au moins 1 des 2 éléments parmi gaz du sang artériel avec lactates et bilan de coagulation/TP-TCA ET justifie que	*1 pt*	☐

	cela permettra de rechercher des signes de gravité/défaillances d'organe		
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			
1.	**8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES**		

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

2.

Aptitude à planifier les soins (= approche centrée sur le patient)

Performance insuffisante 0 point	Performance limite 0,25 point	Performance satisfaisante 0,5 point	Performance très satisfaisante 0,75 point	Performance remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins.	Le projet des soins est adapté au tableau clinique. Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient.	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie.

TOTAL (max 20 items)	**X points**

Éléments de rétroaction :

- Il est important de bien savoir interpréter l'ensemble d'un bilan biologique et dire aussi ce qui est normal.
- Il faut utiliser les mots médicaux et ne pas simplement répéter les valeurs en disant si elles sont augmentées ou abaissées. Par exemple ne pas dire ASAT et ALAT augmentées mais cytolyse hépatique
- Il faut mettre en rapport le bilan biologique avec la clinique pour avoir un tableau global cohérent
- Un diagnostic doit toujours être justifié. Il doit comporter tous les éléments, ici oui il y a une pancréatite mais celle ci est grave et compliquée d'un SRIS, il ne faut pas oublier de le mentionner car cela change en partie les examens complémentaires à demander et la prise en charge.
- Les éléments de gravité peuvent être cliniques mais aussi biologiques, il faut connaître les scores
- Tout examen demandé doit être justifiable, on ne fait pas de bilan "systématique" donc avant de citer un examen réfléchissez à pourquoi vous le demandez.

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Donner dès le début de la station à l'étudiant la fiche des urgences avec l'histoire et le bilan biologique

Documents présents dans la station :

FICHE D'ENTRÉE DES URGENCES DE M. P, 55 ans

MOTIF D'ADMISSION : douleur abdominale aigue

ANTÉCÉDENTS :

- Notion de douleurs abdominales < 6h récidivantes en hypocondre D, jamais bilantées
- HTA
- Dyslipidémie
- Obésité avec IMC 32
- OH chronique 4 verres/j
- Tabagisme actif 34 PA

HISTOIRE DE LA MALADIE : Le patient a présenté ce matin une douleur épigastrique intense EVA 8/10, transfixiante, non soulagée par le paracétamol. Il est soulagé par la position en chien de fusil. Vomissements. Pas de défense ni contracture. Dernières urines peu abondantes et foncées il y a 5h.

CONSTANTES :

- FC 110 bpm
- TA 135/87 mmHg
- Saturation 91% en aa
- FR 25/minute
- T° 38,2°C

BILAN BIOLOGIQUE :

- Hb 14,4 g/dL, plaquettes 170 G/L
- Leucocytes 13,7 G/L dont PNN 9,6 G/L, lymphocytes 3,1 G/L
- K+ 4,5 mmol/L, Na 142 mmol/L
- Creatinine 76 umol/L, urée 11 mmol/L
- ASAT 230 U/L (8-30), ALAT 163 U/L (8-35), PAL 140 U/L (40-129), GGT 86 UI/L (<60), lipase 300 UI/L
- Alcoolémie 1,98 g/L